



GUIA PARA PACIENTES

Infiltração no joelho: o que é, o que esperar e o que a ciência diz

o que um cirurgião de joelho gostaria que você soubesse antes da agulha

A infiltração pode aliviar a dor, mas sozinha não trata a causa. Entenda os tipos, o que cada um mostrou nos estudos, quais são os riscos e quando ela faz sentido.



CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **INFILTRACAO**

Para quem é:

Para quem tem dor no joelho, em geral por **artrose** (desgaste da cartilagem), e recebeu a indicação de uma infiltração, está pensando em fazer uma ou já fez e quer entender o que esperar.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem torceu ou bateu o joelho há poucos dias e ele inchou: primeiro vem a avaliação.
- Quem tem prótese no joelho ou já tem a cirurgia de prótese marcada: converse antes com o seu cirurgião (Página 7).
- Quem tem doença reumática inflamatória, como artrite reumatoide ou gota: os princípios são parecidos, mas a conversa é outra.

O que você vai precisar:

- A lista dos remédios que você usa, principalmente os que "afinam o sangue" (anticoagulantes) e os do diabetes.
- Os exames do joelho que você já tem.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Infiltração é **ferramenta**, e não o tratamento completo. Ela pode abrir uma "janela" de menos dor.

O que você faz dentro dessa janela é o que mais pesa no resultado.

Em geral, a infiltração é um procedimento simples. Mas existe uma complicação rara que é **urgência**: a infecção dentro do joelho. **Leia esta página antes de qualquer outra e deixe-a à mão nos dias seguintes à aplicação.**

Procure atendimento HOJE se, nos dias seguintes à infiltração:

- Você tiver **febre** ou calafrios.
- O joelho ficar **muito vermelho, quente e inchado**, e piorando a cada dia.
- A **dor piorar muito depois de 48 horas**, em vez de ir melhorando.
- A dor impedir você de apoiar a perna ou de dobrar o joelho.

Num estudo dinamarquês com mais de 14 mil infiltrações de corticoide em várias articulações, a infecção apareceu em **menos de 1 a cada 1.000** [10]. É rara, mas exige tratamento rápido. E a **febre aparece em só cerca de metade dos casos** de infecção na articulação [11]: joelho muito quente e dolorido também merece avaliação no mesmo dia, mesmo sem febre.

Procure um pronto-socorro imediatamente se:

- Logo depois da injeção surgir **falta de ar, inchaço no rosto ou na garganta** ou **manchas pelo corpo**. A reação alérgica grave é muito rara, mas é emergência (opinião clínica).

Uma observação honesta: algum incômodo nas primeiras 24 a 48 horas é comum e costuma passar sozinho (opinião clínica). O que preocupa é a **piora depois disso**.

O que é

Infiltração é uma injeção de medicamento **dentro da articulação** do joelho. Em geral, o objetivo é diminuir a dor e a inflamação por um tempo.

O que vem primeiro

As principais diretrizes internacionais de artrose do joelho concordam num ponto. A **base do tratamento** é:

- **Informação** sobre a doença.
- **Exercício** orientado, principalmente o fortalecimento.
- **Controle do peso**, para quem está acima do peso.

A Sociedade Internacional de Pesquisa em Artrose (OARSI) chama esse conjunto de tratamento "central" [1]. O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) recomenda **fortemente** o exercício e a perda de peso [2].

Uma revisão Cochrane mostrou que o exercício reduz a dor e melhora a função, com um efeito que se mantém por pelo menos 2 a 6 meses depois do fim do programa [4].

Exercício e infiltração, frente a frente

Num estudo americano com 156 pessoas, quem fez **fisioterapia** tinha **menos dor e melhor função depois de 1 ano** do que quem recebeu infiltração de corticoide [7].

A infiltração entra **junto** com o básico, nunca **no lugar** dele.

O corticoide é um anti-inflamatório potente. Entre as infiltrações, é a mais antiga e a mais estudada.

O que esperar

Somando os estudos, a revisão Cochrane encontrou [5]:

- Alívio **moderado** nas primeiras 1 a 2 semanas.
- Alívio **pequeno a moderado** entre 4 e 6 semanas.
- Efeito **pequeno** em 3 meses e **nenhum** em 6 meses.

Os próprios autores consideram limitada a qualidade dos estudos [5].

As diretrizes aceitam o corticoide, com força diferente: o ACR recomenda **fortemente** [2]; a OARSI, de forma **condicional** [1]; e a Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas (AAOS) afirma que ele pode dar **alívio de curto prazo** [3].

E repetir várias vezes?

Num estudo de 2 anos, 140 pessoas com artrose receberam corticoide ou soro **a cada 3 meses**. O grupo do corticoide teve **um pouco mais de perda de cartilagem** na ressonância e **não teve menos dor** do que o grupo do soro [6]. A diferença na cartilagem foi pequena, e o efeito dela a longo prazo é incerto. Mesmo assim, o estudo não apoia o uso repetido por longos períodos [6].

Na minha prática (opinião clínica): uso o corticoide para atravessar uma crise e permitir o exercício, com aplicações espaçadas. Não uso como "manutenção" a cada poucos meses.

Aqui a ciência **não chegou a um consenso**, e as diretrizes **discordam entre si**. Digo isso com clareza porque essas injeções costumam ser apresentadas como solução.

Ácido hialurônico ("viscossuplementação")

É uma substância parecida com o líquido natural do joelho.

- Uma grande revisão publicada no BMJ (24 estudos grandes, quase 9 mil pessoas) encontrou uma redução de dor **pequena demais para ser percebida** e um pequeno aumento de eventos adversos graves [8].
- O ACR recomenda **contra**, de forma condicional [2]. A AAOS **não recomenda o uso de rotina** [3]. A OARSI aceita de forma condicional [1].

PRP (plasma rico em plaquetas)

É preparado a partir do seu próprio sangue.

- No estudo com placebo que acompanhou 288 pessoas por 12 meses, o PRP **não foi melhor do que uma injeção de soro** na dor nem na cartilagem [9].
- O ACR recomenda **fortemente contra** [2]. A AAOS diz que ele **pode** reduzir a dor, com evidência **limitada** [3].

"Células-tronco" e outros biológicos

O ACR recomenda **fortemente contra** as injeções de "células-tronco" na artrose do joelho [2]. Faltam estudos sólidos que mostrem regeneração de cartilagem (opinião clínica baseada nas diretrizes).

Ser "natural" ou "do próprio corpo" não prova que funciona.

Quando costumo considerar (opinião clínica)

- **Crise de dor** na artrose, muitas vezes com o joelho inchado, que está impedindo o exercício.
- Quem **já faz** exercício e controle de peso e ainda tem dor que atrapalha.
- Quem **não pode ou não quer operar** agora e precisa de um alívio temporário.

Quando costumo NÃO indicar (opinião clínica)

- Como **primeiro e único** tratamento, sem exercício.
- Com ferida na pele ou infecção perto do joelho.
- Quando a dor **não vem de dentro da articulação**, como a dor de um tendão ou a que vem da coluna.

Riscos, com honestidade

- **Infecção:** rara, mas grave (Página 3) [10].
- **Dor e inchaço** nas primeiras 24 a 48 horas (opinião clínica).
- **Açúcar no sangue mais alto** por alguns dias depois do corticoide, em quem tem diabetes. Meça a glicemia com mais atenção (opinião clínica).
- **Roxo ou sangramento** no local, mais comum em quem usa anticoagulante (opinião clínica).
- **Corticoide repetido** e cartilagem (Página 5) [6].

Tem prótese marcada?

Um estudo associou infiltrações feitas **nos 3 meses antes da prótese** a mais infecção na prótese [12]; uma revisão não encontrou essa relação [13]. Por cautela, avise sempre o seu cirurgião (opinião clínica).

Antes

Como fazer: leve a lista de remédios. Avise se usa anticoagulante, se tem diabetes, alergia, ferida na perna, febre recente ou cirurgia marcada.

Sensação correta: saber qual substância será aplicada, por quê e o que esperar dela.

Erro comum: esconder um remédio ou uma febre recente "para não atrapalhar".

Na hora

Como fazer: a pele é limpa com antisséptico e a injeção é feita com técnica estéril, em geral com você deitado e o joelho relaxado. Se o joelho estiver muito inchado, o excesso de líquido pode ser retirado antes.

Sensação correta: uma picada e, por alguns minutos, uma sensação de pressão ou de "joelho cheio".

Erro comum: contrair a coxa com força. Com o músculo relaxado, fica mais fácil.

Depois

Como fazer: nas primeiras 24 a 48 horas, só atividades leves, sem treino pesado. Gelo com um pano entre ele e a pele, se ajudar. Depois disso, retome o exercício aos poucos (opinião clínica).

Sensação correta: incômodo leve, que melhora a cada dia.

Erro comum: sentir alívio e voltar direto ao esforço máximo, ou achar que, como a dor passou, o exercício não é mais necessário.

O objetivo é usar a "janela" de menos dor para construir o que dura: força e movimento [4][7].

Dias 1 e 2 — Calma

- Atividades leves e caminhadas curtas.
- Fique de olho nos sinais da Página 3.

Semanas 1 e 2 — Retomar

- Volte ao exercício orientado, com carga leve.
- Caminhada no tempo que for confortável.

Semanas 3 a 6 — Construir

- Progrida **uma coisa de cada vez**: mais repetições **ou** mais carga.
- Mantenha o controle do peso, se for o seu caso.

Os prazos são um ponto de partida prático, e não um protocolo testado (opinião clínica).

Rastreador

	Dor média (0–10)	Dor máxima no dia (0–10)	Fez o exercício? (S/N)	Joelho inchado? (S/N)	Sinal da Página 3? (S/N)
Antes					
Dia 2					
Semana 1					
Semana 2					
Semana 4					
Semana 6					

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para o retorno. Ela mostra quanto tempo o alívio durou, e isso ajuda a decidir o próximo passo.

1. Fazer a infiltração e abandonar o exercício.

O exercício e o controle do peso continuam sendo a base [1][2]. Em 1 ano, a fisioterapia foi melhor que o corticoide [7].

2. Usar corticoide como "manutenção".

O alívio dura semanas [5]. Aplicar a cada 3 meses durante 2 anos não reduziu a dor mais que o soro e trouxe um pouco mais de perda de cartilagem [6].

3. Acreditar que a injeção "regenera" a cartilagem.

No estudo do PRP, a cartilagem não foi diferente da do grupo do soro [9]. O ACR recomenda contra as "células-tronco" [2].

4. Esperar "passar" quando aparecem sinais de infecção.

Febre, joelho vermelho, quente e inchado ou dor piorando depois de 48 horas: procure atendimento hoje (Página 3) [10][11].

5. Não contar ao cirurgião que fez infiltração antes da prótese.

Em parte dos estudos, infiltração nos 3 meses anteriores foi associada a mais infecção [12][13].

Bônus: escolher a injeção pela promessa.

Desconfie de quem garante resultado. Nenhum tratamento tem resultado garantido, e as diretrizes divergem sobre várias dessas injeções (Página 6).

Procure avaliação se:

- A dor no joelho atrapalha o **sono**, o **trabalho** ou a **caminhada** na maioria dos dias, mesmo com exercício e controle de peso.
- Você já fez infiltrações e o alívio está **durando cada vez menos**.
- Recebeu a indicação de uma injeção e quer entender **se ela faz sentido no seu caso**.
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal da Página 3.

Esses critérios são bom senso clínico, e não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa pela **história e pelo exame físico**, com radiografia quando indicada. A infiltração é **uma** das opções. Ela é discutida com você ao lado de exercício, controle de peso, remédios e, em alguns casos, cirurgia. Nem sempre a melhor resposta é uma injeção, e a decisão é tomada em conjunto.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, et al. **OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis.** Osteoarthritis Cartilage. 2019;27(11):1578-1589. doi:10.1016/j.joca.2019.06.011. PMID: 31278997.
2. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, Oatis C, et al. **2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee.** Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(2):149-162. doi:10.1002/acr.24131. PMID: 31908149.
3. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). **Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty): Evidence-Based Clinical Practice Guideline, 3rd edition.** Publicada em 31/08/2021. Disponível em: <https://www.aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/osteoarthritis-of-the-knee/oak3cpg.pdf>
4. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, et al. **Exercise for osteoarthritis of the knee.** Cochrane Database Syst Rev. 2015;1(1):CD004376. doi:10.1002/14651858.CD004376.pub3. PMID: 25569281.
5. Jüni P, Hari R, Rutjes AW, Fischer R, et al. **Intra-articular corticosteroid for knee osteoarthritis.** Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(10):CD005328. doi:10.1002/14651858.CD005328.pub3. PMID: 26490760.
6. McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF, Price LL, et al. **Effect of intra-articular triamcinolone vs saline on knee cartilage volume and pain in patients with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial.** JAMA. 2017;317(19):1967-1975. doi:10.1001/jama.2017.5283. PMID: 28510679.
7. Deyle GD, Allen CS, Allison SC, Gill NW, et al. **Physical therapy versus glucocorticoid injection for osteoarthritis of the knee.** N Engl J Med. 2020;382(15):1420-1429. doi:10.1056/NEJMoa1905877. PMID: 32268027.
8. Pereira TV, Jüni P, Saadat P, Xing D, et al. **Viscosupplementation for knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis.** BMJ. 2022;378:e069722. doi:10.1136/bmj-2022-069722. PMID: 36333100.
9. Bennell KL, Paterson KL, Metcalf BR, Duong V, et al. **Effect of intra-articular platelet-rich plasma vs placebo injection on pain and medial tibial cartilage volume in patients with knee osteoarthritis: the RESTORE randomized clinical trial.** JAMA. 2021;326(20):2021-2030. doi:10.1001/jama.2021.19415. PMID: 34812863.
10. Petersen SK, Hansen I, Andreassen RA. **Low frequency of septic arthritis after arthrocentesis and intra-articular glucocorticoid injection.** Scand J Rheumatol. 2019;48(5):393-397. doi:10.1080/03009742.2019.1584329. PMID: 31146626.
11. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. **Does this adult patient have septic arthritis?** JAMA. 2007;297(13):1478-1488. doi:10.1001/jama.297.13.1478. PMID: 17405973.
12. Avila A, Acuña AJ, Do MT, Samuel LT, et al. **Intra-articular injection receipt within 3 months prior to primary total knee arthroplasty is associated with increased periprosthetic joint infection risk.** Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2022;30(12):4088-4097. doi:10.1007/s00167-022-06942-3. PMID: 35325263.
13. Albanese J, Feltri P, Boffa A, Werner BC, et al. **Infection risk increases after total hip arthroplasty within 3 months following intra-articular corticosteroid injection. A meta-analysis on knee and hip arthroplasty.** J Arthroplasty. 2023;38(6):1184-1193.e2. doi:10.1016/j.arth.2022.12.038. PMID: 36592824.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

